

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient's Copy Cystoscopy and Removal of Bladder Tumor

معلومات الإقرار – نسخة المريض منظار المثانة البولية و استئصال ورم المثانة البولية

1. What do I need to know about this procedure?

A cystoscopy is where the doctor looks and examines the inside of the bladder and urethra using a fine telescopic-type instrument called a cystoscope.

The tumor will be resected. If the tumor is unresectable a biopsy will be taken

2. My anesthetic

This procedure will require an anesthetic. See

About Your Anesthetic information sheet

for information about the anesthetic and the risks involved. If you have any concerns discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following:

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may

1. ما الذي ينبغي عليّ معرفته عن هذا الإجراء؟

منظار المثانة البولية هو إجراء يتم من خلاله الطبيب من رؤية وفحص المثانة البولية والإحليل (قناة مجرى البول) من الداخل باستخدام أداة دقيقة من الأدوات المستخدمة في التقريب تسمى المنظار.

يتم استئصال الورم بالكامل. في حال كان من الصعب إزالة الورم يتم أخذ عينة من الورم.

2. التخدير الذي أتلقيه

سوف يتطلب هذا الإجراء تخدير .
اقرأ ورقة تعليمات التخدير المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة عليه . إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات ، قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج.

إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها.

3. ما هي مخاطر هذا الإجراء بالتحديد؟

هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات ، وهي تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى يتطلب علاجها المضادات الحيوية وعلاجات أخرى.
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافكس أو اسكوفير) أو عقار دايبيبريدامول (بيرسانتن أو اساسانتين).
- قد يحدث انهيار (انطباق) لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند أصحاب الأوزان الزائدة ، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية.
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مما

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

break off and go to the lungs.

- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Rarely damage to the urethra. A false passage may be produced causing leakage of urine or in the long term, a narrowing that may affect flow of urine.
- Damage to the bladder by puncturing the bladder wall. This may need further surgery.
- Swelling at the exit of the bladder stopping passage of urine. This may need a catheter (urine drainage tube) until the swelling goes down.
- Bacteria may get into the blood stream with the development of septicaemia. Treatment with antibiotics may be required.
- Bleeding which may stain the urine color and sometimes cause blockage of urine flow.
- Burning and scalding of urine for a few days after the procedure. This usually settles.
- Heavy bleeding from the tumor with passage of blood and possible clot retention of urine. A tube(catheter) may need to be inserted to drain the urine until the bleeding stops.
- A catheter may be left in the bladder for a few days. Often there will be continual irritation of the bladder.

Notes to talk to my doctor about:

- يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة:

- من النادر حدوث ضرر للإحليل (قناة مجرى البول) . قد يتكون ممر خاطئ مما يتسبب في تسرب البول ، أو على المدى البعيد قد يحدث ضيق يؤثر على جريان البول.
- ضرر للمثانة البولية بسبب إحداث ثقب في جدارها . قد يتطلب ذلك جراحة أخرى.
- تورم في مخرج المثانة البولية مما قد يمنع مرور البول. قد تكون هناك حاجة لإدخال أنبوب (قسطرة) لتصريف البول لحين تعافي التورم.
- قد تدخل البكتيريا إلى مجرى الدم ويحدث تسمم (تجرثم) للدم. قد تكون هناك حاجة للعلاج بالمضادات الحيوية.
- حدوث نزيف قد يؤدي إلى تغيير لون البول وقد يعيق أحياناً تدفق البول.
- حرارة و حرقان في البول لعدة أيام بعد الإجراء . عادةً ما يتعافى ذلك.
- نزيف شديد من الورم مع خروج للدم ، واحتمال أن يسبب التخثر الدموي احتباس للبول. قد تكون هناك حاجة لإدخال أنبوب (قسطرة) لتصريف البول حتى يتوقف خروج الدم.
- قد تترك القسطرة البولية في المثانة لعدة أيام . عادة ما يكون هناك تهيج مستمر للمثانة البولية.

أمور أتأقش حولها مع طبيبي:
